

9. 27. Cetuximab(如 Erbitux)：(96/3/1、98/7/1、98/8/1、99/10/1、101/12/1、104/11/1、106/1/1、106/4/1、107/6/1、110/6/1、111/2/1、112/12/1、113/6/1、115/2/1、115/5/1)

1. 直腸結腸癌治療部分：

(1)與 FOLFIRI (Folinic acid/ 5-fluorouracil/irinotecan) 或 FOLFOX (Folinic acid/ 5-fluorouracil/oxaliplatin) 合併使用於治療 RAS 原生型(wild-type)之轉移性直腸結腸癌病人之第一線治療。需檢附 A11-RAS 基因突變分析檢測報告，且需符合全民健康保險藥品給付規定之通則十二。(101/12/1、104/11/1、106/1/1、110/6/1、113/6/1、115/2/1)

I. 本藥品須經事前審查核准後使用，每次申請之療程以18週為限，再次申請必須提出客觀證據(如：影像學)證實無惡化，才可繼續使用。

II. Cetuximab 與 panitumumab 二者僅能擇一使用。(101/12/1、106/1/1、107/6/1、115/2/1)

III. 本藥品不得與 bevacizumab 併用。

IV. 經手術完全切除(R0切除)且查無轉移病灶者不得申請給付。(115/2/1)

(2)與 encorafenib 併用，作為具有 BRAF V600E 突變且 RAS 基因沒有突變的轉移性結腸直腸癌成人病人之第二線治療：(115/5/1)

I. 病人須符合 encorafenib 之藥品給付規定，且未曾申報抗表皮生長因子受體(anti-EGFR)藥品之病人使用。

II. 須經事前審查核准後使用，初次申請之療程以12週為限，之後每12週申請一次，再次申請時必須提出客觀證據(如：影像學)證實無惡化，才可繼續使用。

III. 使用總療程以24週為上限。

IV. 使用本品併用 encorafenib 作為第二線治療，不得再申請抗表皮生長因子受體(anti-EGFR)藥品作為後續治療。

(3)與 irinotecan 合併使用，治療已接受過含5-fluorouracil、irinotecan 及 oxaliplatin 二線以上之細胞毒性治療失敗、具有表皮生長因子受體(EGFR)表現型且 K-RAS 基因沒有突變的轉移性直腸結腸癌的病人，且於115年1月31日前經審核同意用藥，後續評估符合續用申請條件者。需檢附 A11-RAS 基因突變分析檢測報告，且需符合全民健康保險藥品給付規定之通則十二。(98/8/1、110/6/1、113/6/1、115/2/1)

I. 本藥品須經事前審查核准後使用，每次申請之療程以9週為限，再次申請必須提出客觀證據(如：影像學)證實無惡化，才可繼續使用。

II. 使用總療程18週為上限。

2. 口咽癌、下咽癌及喉癌治療部分：(98/7/1、99/10/1、111/2/1、115/2/1)

(1)限與放射線療法合併使用於局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌病人，且符合下列條件之一：

I. 70歲以上(111/2/1)；

II. Ccr<50mL/min；

III. 聽力障礙者(聽力障礙定義為500Hz、1000Hz、2000Hz 平均聽力損

失大於25分貝)；

IV. 無法耐受 platinum-based 化學治療。

(2)須經事前審查核准後使用，每位病人每12週申請一次，需無疾病惡化情形方得繼續使用。(98/7/1、115/2/1)

3. 頭頸癌部分(106/1/1、106/4/1、112/12/1、115/2/1)：

(1)限無法接受局部治療之復發及/或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌，且未曾申報 cetuximab 之病人使用。

(2)須經事前審查核准後使用，每位病人每12週申請一次，需無疾病惡化情形方得繼續使用。(106/4/1、115/2/1)